TÓM TẮT LÝ THUYẾT · MẮT

BÀI 2 Viêm kết mạc

Tóm tắt từ bài giảng 2. Conjunctivitis - Diagnosis & Treatment.pdf (20 trang) · Giữ ý chính và dấu hiệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. GIẢI PHẪU, MÔ HỌC VÀ CHỨC NĂNG KẾT MẠC
2. ĐẠI CƯƠNG VÀ CHẨN ĐOÁN
3. TRIỆU CHỨNG
4. VIÊM KẾT MẠC DO VI KHUẨN
5. VIÊM KẾT MẠC DO VIRUS
6. VIÊM KẾT MẠC DỊ ỨNG

1. GIẢI PHẪU, MÔ HỌC VÀ CHỨC NĂNG KẾT MẠC

- **Màng nhầy mỏng, trong suốt**, trải từ **rìa giác – củng mạc** đến **chỗ nối da – niêm của mi mắt**.
- Gồm 3 phần: **kết mạc nhãn cầu**, **kết mạc cùng đồ**, **kết mạc mi**. Có thể quan sát bằng mắt thường và khi **nhuộm fluorescein**.
- **Cấp máu:** động mạch mi và **động mạch mi trước**, bắt nguồn từ **động mạch lệ** và động mạch mũi của mi mắt. Tĩnh mạch kết mạc → tĩnh mạch mi → tĩnh mạch cơ.
- **Thần kinh: V1 và V2**.
- **Biểu mô: 5 lớp tế bào trụ lát tầng, không sừng hóa**; xen kẽ **tế bào đài** tiết chất nhầy; khoảng gian bào chứa kháng thể.
- **Nhu mô:** mô liên kết lỏng lẻo, **giàu mạch máu**; nhiều **tuyến lệ phụ Krause, Wolfring**.
- **Chức năng: bảo vệ** (hàng rào chống vi sinh vật), **bôi trơn** (chất nhầy, nước mắt), **bảo vệ miễn dịch** bề mặt nhãn cầu.

2. ĐẠI CƯƠNG VÀ CHẨN ĐOÁN

- Bệnh **thường gặp** trong nhãn khoa: tập trung tế bào viêm và chất xuất tiết do **giãn mạch máu kết mạc**.
- Nguyên nhân chính: **vi khuẩn, virus, dị ứng**. **Cấp ≤ 3 tuần**, **mạn > 3 tuần**.
- Chẩn đoán: **lâm sàng là chủ yếu**; có thể soi tươi, **nhuộm Gram, Giemsa**, **nuôi cấy + kháng sinh đồ**.

3. TRIỆU CHỨNG

- **Cơ năng: đỏ mắt, không đau, không giảm thị lực**; sưng nề mi; ngứa, rát, nóng; chảy nước mắt hoặc chất tiết. Có biến chứng giác mạc thì **đau nhức, cộm xốn, cảm giác dị vật, mờ mắt**.
- **Chất tiết gợi ý nguyên nhân:**

Chất tiết	Gợi ý
Dạng nước	Virus hoặc dị ứng
Dạng nhầy	Khô mắt hoặc dị ứng mạn tính
Dạng mủ	Vi khuẩn

- **Thực thể khác:** phù kết mạc, sung huyết, **phản ứng nang**, xuất huyết dưới kết mạc, **phản ứng nhú**, màng kết mạc, sẹo kết mạc, **phản ứng hạch lympho**.

4. VIÊM KẾT MẠC DO VI KHUẨN

- **Cấp tính, thường 2 mắt** (có thể 1 mắt trước, **1–2 ngày sau** lan sang mắt kia).
- **Chất tiết mủ, dính mi buổi sáng**; có thể kèm triệu chứng toàn thân khi nhiễm **lậu cầu, não mô cầu**.

- Thực thể: **sưng nề mi (lậu cầu)**; thường **phản ứng nhú**, ít phản ứng nang; có thể tổn thương biểu mô giác mạc, **màng giả, màng thật**.
- **Điều trị:** tự hồi phục sau **1–2 tuần**; điều trị đúng thì khỏi sau **1 tuần**, giảm tái phát và lây nhiễm.
  - **Kháng sinh phổ rộng:** Gentamycin, Tobramycin, Ciprofloxacin, Ofloxacin...
  - **Thuốc nhỏ 4–6 lần/ngày**; **thuốc mỡ 1–2 lần, trước khi ngủ**.

5. VIÊM KẾT MẠC DO VIRUS

- **Adenovirus:** 4 thể – **sốt họng hạch**, **viêm kết – giác mạc thành dịch**, phản ứng nang cấp không đặc hiệu, viêm kết mạc mạn; có thể biến chứng **viêm giác mạc chấm nông (thường sau 2 ngày)**, thâm nhiễm dưới biểu mô.
- **Herpes simplex:** nguyên phát hoặc thứ phát; tương đối nhẹ, **trừ trẻ sơ sinh**; sang thương điển hình ở **da mi**, kết mạc, giác mạc, màng bồ đào; **đa số 1 mắt**.
- **Điều trị: vệ sinh mắt, tránh lây lan**; điều trị triệu chứng, nâng sức đề kháng; **kháng sinh chỉ để ngừa bội nhiễm**; **thuốc kháng virus không hiệu quả**; **corticoid liều thấp** cân nhắc kỹ.

6. VIÊM KẾT MẠC DỊ ỨNG

- **Cơ năng: 2 mắt**, **ngứa**, đỏ, sưng, chảy nước mắt, **chất tiết trong**, **tiền căn dị ứng**.
- **Thực thể:** phù mi, phù kết mạc, **phản ứng nhú**, có thể tổn thương giác mạc, **không có phản ứng hạch**.
- **Điều trị: hạn chế tiếp xúc dị nguyên**, **chườm lạnh**; tại chỗ: nước mắt nhân tạo, **kháng histamin, co mạch, ổn định dưỡng bào**, corticoid; toàn thân: **kháng histamin uống**.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế bài giảng gốc. Đối chiếu 2. Conjunctivitis - Diagnosis & Treatment.pdf khi cần chi tiết.